

Fecha Última Actualización: 07-01-2026 11:45:51

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Juan Guillermo Chinga Flores

Rut : 10.205.418-0

N° Archivo : 1718446

N° Epicrisis
467935

Edad : 61a 3m 20d

Fecha Nacto: 18/09/1964

Sexo : Masculino

Dirección : Los Corregidores 0794 San Geronimo

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 974458915

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 03/01/2026 05:29

Días Estadía: 4

Unidad de Egreso : Medicina Agudos 2° Piso

Fecha Egreso : 07/01/2026 11:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

fiebre intradiálisis

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS SALA MEDICINA 07/01

Datos de paciente

Nombre: Juan Guillermo Chinga Flores

RUT: 10.205.418-0

Edad: 61 años

FI CASR: 03/01/26

FI UTIM: 03/01/26

FI sala: 05/01/26

ANTECEDENTES:

Mórbidos: ERC en HD (L-M-V 2do turno en HSR) por tunelizado, HTA, DM2, FA en TACO, COVID grave en 2022 (estuvo en UPC, salida a TQT ya retirada)

Quirúrgicos: confección de FAV

Fármacos: Acenocumolol, losartán, Complejo b 1 vez al mes, Venofer 100 mg mensual, Bisoprolol 2.5 mg, comprimido c/24 horas vía oral, Cinacalcet 60 mg al día, Furosemida 40 mg 1 comprimido c/12 horas, Atorvastatina 20 mg, 1 comprimido c/24 horas, Ácido Fólico 1 mg, 1 comprimido c/24 horas, Risperidona 1 mg, 1/2 comprimido c/24 horas

Alergias: niega

Hábitos: TBQ (-) oh (ocasional) drogas (-)

Hospitalizaciones recientes: Junio 2025 CHD disfuncional, noviembre 2025 por FA con RVR.

Social: : Trabaja como guardia de hotel, vive solo en casa, independiente para todas las actividades

MC: fiebre intradiálisis

HISTORIA:

Paciente el día del ingreso acude a su diálisis, durante la cual presenta episodio de cefalea, sensación febril con calofríos. Presenta además tos seca desde el día anterior, y disnea leve. Niega rinorrea, congestión nasal, odinofagia, síntomas digestivos o urinarios. Niega dolor torácico. Sin alteraciones cutáneas o dolor en zona de fístula. En diálisis requiere apoyo con 2L/min de O2 por naricera para saturar 94%, por lo que se deriva a SU.

Fecha Epicrisis : 07/01/2026 11:45

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:31

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 07-01-2026 11:45:51

Página 2 de 4

Ingres a la servicio de urgencia normocárdico, hipertenso (197/87 mmHg), afebril, saturando 94% con 2 L O₂ por NRC. Al examen físico en urgencias destaca sin conflicto perfusional, crépitos difusos en ambos campos pulmonares, edema de extremidades inferiores ++/++.

En exámenes de laboratorio destaca elevación de parámetros inflamatorios, sin urgencia dialítica. Se realiza TAC de tórax que muestra opacidades con densidad en vidrio esmerilado pulmonares bilaterales, leve derrame pleural bilateral. moderada cardiomegalia global.

Durante estadía en SU se conecta a VMNI modo CPAP, además se realiza UFA 03/01, con lo cual logra ventana de CPAP. Inicia ATB con ceftriaxona y CS con hidrocortisona. Ingres a UTIM para continuar manejo.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

1. Insuficiencia respiratoria multifactorial

a. NAC

b. EPA hipertensivo/nefrogénico

2. Fiebre intradiálisis

a. NAC vs ITS CHD

3. Antecedentes: ERC en HD, HTA, DM2

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN UTIM-SALA:

HDN: Ingres a con crisis hipertensiva con EPA secundario, inicialmente manejado con BIC NTG con buena respuesta, titulando vasodilatadores al alza, logrando suspensión de BIC 04/01 AM, posteriormente con buenas cifras tensionales. Se realiza manejo de VEC expandido con furosemida (con escasa diu 200 cc), junto con HD. Por hiperkalemia se cambia losartán a isosorbide con buena respuesta.

Respiratorio: impresiona EPA con probable NAC sobreagregada, manejo con terapia depleitiva, ATB, KNT R, VMNI, sin requerimiento de conexión desde 04/01 AM. Se mantiene con requerimiento 1L de oxígeno. Evoluciona favorablemente, suspende O₂ por NRC el 06/01. Completa 24 hrs de observación sin incidentes por lo que se encuentra en condiciones de alta.

Infeccioso: ingresa por episodio de fiebre intra HD asociado a PPII elevado, pero con síntomas respiratorios y TAC sospechoso de NAC. HC periféricos y arrastre negativos de momento (día 5), pendiente rescatar resultado final. PCR COVID (+), se inicia protocolo Recovery hasta suspensión de apoyo de O₂ por NRC. Se mantiene con ampi-sulbactam + azitromicina (FI: 03/01) con plan de completar 5 días de ATB

Nefrológico: paciente con ERC en etapa V en HD trisemanal en este centro. Ingres a sin urgencia dialítica a este centro pero con requerimiento de UFA el 03/01. Se mantiene con su esquema de HD habitual, bien tolerado.

ETE: usuario de TACO. Tromboprofilaxis durante estadía. Se reinicia TACO el 05/01 pero dado INR en rango sub terapéutico se inicia BIC de HNF con rango meta de TTPK 50-80. Se indica reiniciar TACO al alta con plan de control precoz en poli TACO para ajuste.

EXÁMENES RELEVANTES

LABORATORIO

06/01: ELP 141/4.81/103 pH 7.38 pCo₂ 27.8 HCO₃ 16.2 BUN 68.1 P 6.6 Hb 8.6 Gb 5490 PLQ 123000

05/01: Alb 3.4 Ca 8.3 BUN 82 P 5.2 Mg 2.2 PT 7.3 PCR 103 ELP 144/5.4/103 GS (pH 7.34 CO₂ 33 HCO₃ 18) Hb 9.2 GB 4.950 Plaq 128k INr 1.05 TTPa 26

03/01/26 PM: Hto 23.8, Hb 8.3, GB 5170, Plaq 97.000, GSV pH 7.433 pCO₂ 39.7 HCO₃ 26, crea 10.5, BUN 46.8, ELP 147/5.13/103, PCR 171.8.

MICROBIOLOGÍA

03/01: HC I y II: pendientes, HC CHD: pendientes. Panel respiratorio (-). PCR COVID 19 (+)

IMAGENES

03/01 TAC de tórax: 1. Opacidades con densidad en vidrio esmerilado pulmonares bilaterales. El diagnóstico diferencial debe

Fecha Epicrisis : 07/01/2026 11:45

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 07-01-2026 11:45:51

Página 3 de 4

- considerar edema alveolar versus un origen inflamatorio - Infeccioso.
2. Leve derrame pleural bilateral.
 3. Moderada cardiomegalia global. Signos tomográficos de anemia.
 4. Acentuada atrofia renal bilateral. Nefrolitiasis bilateral.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO.

1. Insuficiencia respiratoria multifactorial resuelta
NAC COVID 19 (+)
EPA hipertensivo/nefrogénico
2. Fiebre intradiálisis
NAC
ITS CHD descartada
3. Antecedentes: ERC en HD, HTA, DM2, FA en TACO, COVID grave en 2022

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Debida A Otros Virus -
Covid-19, Virus Identificado -

Condición de Egreso Otro

Egreso con Catéter Doble J:NO

buenas condiciones, o2 destetado hace mas de 24h.

Plan Post Alta

INDICACIONES AL ALTA:

GENERALES

Reposo relativo, retomar actividades con calma
Régimen hiposódico, bajo en potasio y fósforo.

FÁRMACOS AL ALTA.

Isosorbide 10 mg 1 comprimido cada 12 hrs via oral
Amlodipino 10 mg 1 comprimido cada 24 hrs via oral
Hidralazina 50 mg 2 comprimidos cada 8 h via oral
Furosemida 40 mg 1 comprimido cada 12 hrs via oral
Amoxicilina/Ac clavulánico 500/125 mg 1 comprimido cada 8 horas via oral hasta mañana 08/01 (inclusive)
Azitromicina 500 mg 1 comprimido cada 24 h via oral hasta mañana 08/01 (inclusive)
Bisoprolol 5 mg, tomar medio comprimido cada 24 hrs vía oral
Amiodarona 200 mg 1 comprimido cada 24 h via oral
Cinacalcet 30 mg 2 comprimidos cada 24 horas via oral
Atorvastatina 20 mg 1 comprimido cada 24 h via oral
Ácido Fólico 1 mg 1 comprimido cada 24 h via oral
Acenocumarol por esquema entregado previamente en TACO, ajustar en POLI TACO.
Complejo B administrar 1 vez al mes
Venofer 100 mg administrar 1 vez al mes
Risperidona 1 mg, (medio) comprimido cada 24 horas via oral

Suspender: losartán.

CONTROLES

Control en Poli TACO
Acudir al centro de hemodiálisis de referencia trisemanal (L-M-V).
Control con medicina interna para seguimiento de patologías crónicas

ACUDIR AL SERVICIO DE URGENCIAS SI: dificultad respiratoria, compromiso de conciencia, fiebre $>39^{\circ}\text{C}$, dolor torácico o cuando estime conveniente.

Indicaciones

Fecha Epicrisis : 07/01/2026 11:45

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 07-01-2026 11:45:51

Página 4 de 4

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Bec. Felipe Fuentes Velasco

Becado/Residente

Sebastián Oksenbeg Sharim

Médico Tratante (Staff)